



4.3.1. Escala de Síndromes Prodrómicos (Scale of Prodromal Syndromes, SOPS)

1

SOPS

ESCALA DE SÍNDROMES PRODRÓMICOS (idioma español)

VERSIÓN PARA MEDIDAS REPETIDAS

PRIME Clínica de Investigación
Escuela de Medicina de Yale
New Haven, CT

Thomas H. McGlashan, M.D.
Tandy J. Miller, Ph.D.
Scott W. Woods, M.D.
Joanna L. Rosen, Psy.D.
Ralph E. Hoffman, M.D.
Larry Davidson, Ph.D.

París, 3 de marzo, 2002 – Versión en español 3.1
Julio Bobes*, Celso Arango**, Teresa Bobes-Bascarán,
M.^a Teresa Bascarán* y Mara Perellada**

Copyright ©2001 Thomas H. McGlashan, M.D

*Universidad de Oviedo. **Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Instrucciones para el evaluador

Los objetivos de la escala son evaluar la gravedad de los síndromes prodrómicos y medir los cambios de los síndromes prodrómicos con el tiempo. Esta escala está destinada para usarse en pacientes a los cuales les ha sido diagnosticado algún «síndrome prodrómico» siguiendo el Criterio de Síndromes Prodrómicos (CSP), utilizando la Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (SIPS).

El marco temporal para esta evaluación se define como el tiempo desde que se realizó la última evaluación. Una entrevista SIPS debe llevarse a cabo en lugar de una SOPS-RM, si el tiempo transcurrido desde la última evaluación es igual o mayor a 6 meses. La información deberá comenzar con un recordatorio sobre cuánto tiempo ha transcurrido desde que se obtuvo la última evaluación y sobre el desarrollo, la presencia continua y el posible cambio de los síntomas desde entonces.

Para cada ítem, se procede a la evaluación en dos pasos:

PASO 1:

El evaluador debe preguntar primero sobre el estado de algún síntoma preexistente presentado en el informe de alguna de las entrevistas previas SIPS o SOPS.

PASO 2:

El evaluador también debe preguntar después cada cuestión numerada en la sección «Preguntas».

Los «síntomas prodrómicos» se describen y evalúan usando la SOPS (Escala de Síndromes Prodrómicos). La SOPS tiene dos escalas, una para evaluar **síntomas positivos** otra para **síntomas negativos/de desorganización/generales**.

La evaluación de los síntomas positivos en la SOPS oscila de 0 (ausente) a 6 (grave y psicótico).

SOPS para síntomas positivos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
---------------------	------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Si se evalúan síntomas negativos/de desorganización/generales, la escala SOPS oscila de 0 (ausente) a 6 (extremo).

SOPS para síntomas negativos/de desorganización/generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
---------------------	------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

Ítems de síntomas positivos

Especificaciones: Para cada respuesta positiva a una pregunta, el entrevistador debe usar especificaciones para obtener más información detallada.

- Comienzo-Duración-Frecuencia
- Grado de angustia: ¿cómo es esta experiencia para usted? (¿le molesta?)
- Grado en el que interfiere con la vida: ¿actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Ha hecho alguna vez algo diferente debido a esta experiencia?
- Grado de convicción/significación: ¿cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto podría estar sólo en su cabeza? ¿Piensa que esto es real?

P. SÍNTOMAS POSITIVOS

P.1. CONTENIDO DEL PENSAMIENTO INUSUAL/IDEAS DELIRANTES

Preguntas

1. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que algo extraño o malo está ocurriendo y no puede explicar...? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Ha notado algún nuevo/otro cambio en sus pensamientos, como que sus pensamientos son dichos en alto o sentimientos como que otra gente puede leer sus pensamientos? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Le ha dicho alguien que sus ideas y creencias son inusuales o extrañas? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.1. DESCRIPCIÓN

- a Perplejidad y humor delirante. Engaños mentales como por ejemplo la sensación de que algo extraño está ocurriendo, perplejidad, y confusión sobre lo que es real o imaginario. Lo familiar parece extraño, confuso, amenazador, o tiene un significado especial. Sensación de que usted mismo, otros, el mundo ha cambiado. Cambios en la percepción del tiempo. *Déjà vu*.
- b Ideas no persecutorias de referencia.
- c Fenomenología de primer rango. Acontecimientos mentales como inserción de pensamiento, interferencia, aislamiento, difusión, telepatía, control externo, mensajes de radio y televisión.
- d Ideas sobrevaloradas. Preocupación con ideas inusualmente valoradas (religión, mediación, filosofía, temas existenciales). Pensamiento mágico que influye en el comportamiento y es inconsistente con las normas subculturales (p. ej., supersticiones, creencia en la clarividencia, creencias religiosas no comunes).
- e Ideas inusuales sobre el cuerpo, culpa, nihilismo, envidia y religión. Los delirios podrán estar presentes pero no están bien organizados y se mantendrán de forma tenaz.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

CONTENIDO DEL PENSAMIENTO INUSUAL/IDEAS DELIRANTES

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
«Trucos mentales» que son confusos. Sensación de que algo es diferente	Sobreinterés en la vida fantástica. Ideas/creencias inusualmente valoradas. Algunas supersticiones por encima de las que puedan observarse para una persona media dentro de unas normas culturales	Acontecimientos mentales no anticipados/ideas no persecutorias de referencia/ trucos mentales/pensamiento mágico que no es fácilmente rechazado y puede ser irritante o preocupante. Una sensación de que estas experiencias o estas creencias convincentes nuevas están llegando a ser significativas porque ellas no se irán	Noción de que las experiencias vienen desde fuera de uno mismo o que las ideas/ creencias pueden ser reales, pero el escepticismo se mantiene intacto. Generalmente no afecta al funcionamiento	Creencia en la realidad de los «trucos mentales»/ acontecimientos mentales/pensa- miento mágico; es convincente, pero puede inducir evidencias contrarias y opiniones de otros. Puede afectar al funcionamiento	Convicción delirante (sin ninguna duda) al menos intermi- tentemente. General- mente interfiere con el pensamiento, las relaciones sociales o los comportamientos	

Puntuación basada en:

P.2. IDEAS PERSECUTORIAS/SUSPICACIA

Preguntas

1. ¿Cómo se ha estado sintiendo con gente a su alrededor? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Ha tenido pensamientos de que las personas hablan sobre usted o dan alguna razón para sentirse desconfiado o suspicaz? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.2. DESCRIPCIÓN

- a Ideas persecutorias de referencia.
- b Pensamiento paranoide o suspicaz.
- c Presenta una actitud encubierta o incluso abierta de desconfianza que puede reflejar convicción delirante y entrometerse en la entrevista y/o comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

IDEAS PERSECUTORIAS/SUSPICACIA

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
	Cautela	Dudas sobre seguridad. Hipervigilancia sin fuente clara de peligro	Nociones de que la gente es hostil, no digna de confianza, y/o fácilmente rencorosa. Sentimiento de que la hipervigilancia puede ser necesaria. Sentimiento recurrente (todavía infundado o exagerado a veces) de que la gente está pensando o diciendo cosas negativas de la persona. Puede parecer desconfiado con el entrevistador	Pensamientos claros o convencidos de ser observado o controlado. Sentimiento de que la gente intenta dañar. Desconfiado. Creencias fácilmente descartadas. La presentación puede parecer cautelosa. Reacio o irritado en respuesta al interrogatorio	Ideas poco organizadas de intenciones peligrosas u hostiles. El escepticismo y la perspicacia se pueden obtener con una prueba u opinión no confirmadas. El comportamiento está afectado en algún grado. La actitud defensiva puede interferir con la habilidad para comunicar la información en la entrevista	Convicción paranoide delirante (sin ninguna duda) al menos de manera intermitente. Probabilidad de afectar el funcionamiento

Puntuación basada en:

P.3. IDEAS DE GRANDIOSIDAD

Pregunta

1. ¿Ha empezado a sentir que es especial de alguna manera o que ha desarrollado algún don, habilidad o talento? (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.3. DESCRIPCIÓN

- a Opinión personal exagerada y sentido irreal de superioridad.
- b Cierta expansividad o alardes.
- c Delirios ocasionales de grandiosidad bien definidos que pueden influir en el comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

IDEAS DE GRANDIOSIDAD

Escala de gravedad (marque una)

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
	Pensamientos privados de ser generalmente superior en intelecto o talento	Pensamientos de ser particularmente talentoso, comprensión elevada o dotado en una o más áreas. Pensamientos que se mantienen mayoritariamente en privado	Nociones de ser inusualmente dotado, poderoso o especial. Puede ser expansivo. Promueve planes significativamente irrealizables, pero reorientados fácilmente	Creencias de poder, riqueza, talento o de habilidades vagamente organizadas. Metas irrealizables que pueden afectar a los planes y al funcionamiento	Creencias persistentes de tener un intelecto no natural, atractivo, poder o fama. El escepticismo sobre la creencia se puede obtener. Suele influir en el comportamiento o en las acciones	Delirios de grandiosidad con convicción (sin ninguna duda) al menos intermitentemente. Afecta al comportamiento y creencias

Puntuación basada en:

P.4. PERCEPCIONES ANÓMALAS/ALUCINACIONES

Preguntas

1. ¿Ha notado algún otro/nuevo cambio en la manera en que las cosas suenan o ha escuchado algo que no estaba seguro de que otras personas hubieran escuchado, como zumbidos, alguien hablando entre dientes, llamando su nombre, sus pensamientos propagados fuera de su cabeza u otras voces débiles o pronunciadas? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Ha notado algún otro/nuevo cambio en la apariencia de las cosas o ha visto algo que no estaba seguro de que otras personas lo hubieran visto como sombras, imágenes borrosas, etc.? S N NI (anote la respuesta)
3. Ha notado alguna otra/nueva sensación inusual? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.4. DESCRIPCIÓN

- a Experiencias de percepción inusuales. Percepciones elevadas o apagadas, imágenes intensas, distorsiones sensoriales, ilusiones.
- b Speudoalucinaciones o alucinaciones que el sujeto intuye (p. ej., es consciente de su naturaleza anómala).
- c Alucinaciones francas ocasionales que pueden influir mínimamente en el pensamiento o el comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PERCEPCIONES ANÓMALAS/ALUCINACIONES

Escala de gravedad (marque una)

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
	Leves pero apreciables cambios en la sensibilidad de la percepción (p. ej., elevada, apagada, distorsionada, etc.)	Inesperados cambios de percepción amorfos que son incomprensibles pero no se consideran significativos	Repetidas imágenes amorfas (sombras, rastros, sonidos, etc.), ilusiones o alteraciones de percepción persistentes que pueden ser preocupantes o experimentadas como inusuales	Ilusiones recurrentes o alucinaciones momentáneas que se reconocen como si no fueran reales aunque pueden ser aterradoras o cautivadoras, y pueden afectar ligeramente al comportamiento. No es segura la fuente de las experiencias	Alucinaciones que ocasionalmente afectan al pensamiento o al comportamiento, que son experimentadas probablemente como fuera de uno mismo o reales. El escepticismo puede ser inducido	Alucinaciones recurrentes percibidas como reales y distintas de los pensamientos de la persona. Clara influencia en el pensamiento, los sentimientos y/o el comportamiento. El escepticismo no puede ser inducido

Puntuación basada en:

P.5. COMUNICACIÓN DESORGANIZADA

Pregunta

1. Evaluar de acuerdo con la observación del entrevistador y el informe colateral (cuando sea relevante).

Especificaciones: Para la respuesta «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.5. DESCRIPCIÓN

- a Forma de hablar extraña. Vaga, excesivamente metafórica, estereotipada.
- b Forma de hablar confusa, desordenada, a carreras o retardada, usando palabras incorrectas, hablando sobre cosas irrelevantes en un contexto o saliéndose del tema.
- c La forma de hablar es circunstancial, tangencial o paralógica. Existe alguna dificultad en dirigir las frases hacia una meta.
- d Presencia de comunicación ininteligible y asociaciones laxas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

Nota. La base para evaluar incluye: comunicación verbal y coherencia durante la entrevista así como el informe de problemas con el pensamiento.

COMUNICACIÓN DESORGANIZADA

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
	Palabra o frase repentina que no tiene sentido	Comunicaciones vagas, confusas, desordenadas, inconsistentes ocasionalmente. Puede salirse del tema brevemente	Ocasionales palabras incorrectas, temas irrelevantes. Frecuentes salidas de tema, pero responde fácilmente ante preguntas aclaratorias. Forma de hablar estereotipada o sobrelaborada	La forma de hablar es claramente circunstancial (p. ej., llegar gradualmente al tema). Alguna dificultad en dirigir las frases hacia una meta. La persona es capaz de ser redirigida a través del interrogatorio y la estructura de la conversación	Las comunicaciones son tangenciales (p. ej., no llegar nunca a la meta). Asociaciones laxas bajo presión. Puede responder con precisión a preguntas breves	La comunicación es imprecisa o irrelevante e ininteligible bajo mínima presión o cuando el contenido de la comunicación es complejo. No responde a la estructura de la conversación

Puntuación basada en:

N. SÍNTOMAS NEGATIVOS

N. 1. ANHEDONÍA SOCIAL O AISLAMIENTO

Preguntas

1. ¿Ha hecho algo con otras personas fuera de la escuela/trabajo? ¿Con qué frecuencia? (anote la respuesta)
2. Describa algunas de sus actividades sociales.

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N. 1. DESCRIPCIÓN

- a Falta de amigos íntimos o confidentes distintos de sus parientes de primer grado.
- b Excesiva ansiedad social que no disminuye con la familiaridad y tiende a ser asociada con miedos paranoides más que con opiniones negativas sobre uno mismo.
- c Incómodo ante la presencia de otros y prefiere pasar el tiempo solo, aunque participe en actividades sociales cuando se le requiere. No inicia el contacto.
- d Acude pasivamente a muchas de las actividades sociales pero de una forma desinteresada y mecánica. Tiende a distanciarse del grupo.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ANHEDONÍA SOCIAL O AISLAMIENTO

Escala de síntomas negativos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Ligeramente incómodo socialmente o ansioso, pero socialmente activo	Está incómodo fácilmente con otros. Desinteresado o ansioso en la mayor parte de las situaciones sociales, pero socialmente presente	Participa socialmente sólo de mala gana debido a la ansiedad o al desinterés. Participación social limitada	Pocos amigos de fuera del entorno familiar. Es desconfiado con otros o socialmente apático	Prefiere estar solo. Pasa la mayoría de su tiempo solo o con parientes de primer grado	No tiene amigos íntimos. Pasa su tiempo solo

Puntuación basada en:

N.2. ABULIA (APATÍA)

Preguntas

1. ¿Ha estado teniendo dificultades para tener hechas cosas o siente menos interés en sus actividades y metas diarias? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Le ha estado empujando alguien a tener hechas las cosas? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.2. DESCRIPCIÓN

- a Alteraciones con la iniciación, persistencia y control de actividades dirigidas a un fin.
- b Pérdida de impulso constructivo.
- c Sentirse desinteresado, hacer las cosas supone más esfuerzo y/o lleva más tiempo hacerlas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

APATÍA

Escala de síntomas negativos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Menos interés en las actividades diarias o metas a largo plazo, pero normalmente productivo	Interés disminuido en las actividades placenteras. Las tareas requieren más esfuerzo y llevan más tiempo aunque se mantiene la productividad	Disminuido interés y productividad. Desajustes en el inicio de las tareas y/o persistencia. El inicio requiere algo de empuje	Evita muchas tareas diarias y/o actividades duraderas. Alguna reducción en los logros. Necesidad de empuje habitualmente	Abandona la mayoría las actividades dirigidas a un fin. Reducción significativa en los logros. Necesidad de empuje todo el tiempo	Abandona casi todas las actividades dirigidas a un objetivo. Empuje sin éxito

Puntuación basada en:

N.3. EXPRESIÓN EMOCIONAL DISMINUIDA

Pregunta

1. Evaluar de acuerdo con la observación de la entrevista y el informe colateral (cuando sea relevante).

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

Nota. La base para evaluar incluye: se observa afecto aplanado además de verbalizar una disminución en la expresión de las emociones.

N.3. DESCRIPCIÓN

- a Respuestas emocionales aplanadas, embotadas, reducidas, como las caracterizadas por una reducción de la expresión facial, modulación de los sentimientos (forma de hablar monótona) y de los gestos de la comunicación (apariencia apagada).
- b Falta de espontaneidad y de fluidez en la conversación. Reducción en la fluidez normal de la comunicación. La conversación muestra poca iniciativa. Las respuestas del paciente tienden a ser breves y sin adornos, requiriendo preguntas directas y mantenidas por el entrevistador.
- c Contacto pobre. Falta de empatía interpersonal, de franqueza en la conversación, de sentido de intimidad, de interés o de implicación con el entrevistador. Esto se evidencia por un distanciamiento interpersonal y comunicación verbal y no verbal reducida.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

EXPRESIÓN EMOCIONAL DISMINUIDA

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Respuestas emotivas ligeramente retrasadas o disminuidas	La conversación carece de vivacidad, está afectada	Mínima expresión emotiva	Dificultad para mantener el flujo y la espontaneidad de la conversación. Forma de hablar mayoritariamente monótona. Mínima empatía interpersonal. Puede que evite el contacto ocular	El inicio y mantenimiento de la conversación requiere de preguntas directas y sostenidas por el entrevistador. Afecto aplanado. Carencia total de gestos	Afecto aplanado, forma de hablar monótona. Incapaz de mantenerse implicado con el entrevistador o de mantener una conversación a pesar de que el entrevistador esté muy inquisitivo

Puntuación basada en:

N.4. RESTRICCIÓN EMOCIONAL Y DEL YO

Pregunta

1. ¿Ha notado algún nuevo/otro cambio en sus emociones? (p. ej., ¿Ha sentido que sus emociones son menos o más fuertes de lo que solían ser o que están desapareciendo o que se siente más emotivo de alguna manera?) **S N NI (anote la respuesta)**

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.4. DESCRIPCIÓN

- a Experiencias emotivas y sentimientos menos reconocibles, genuinos, apropiados.
- b Sensación de distancia cuando habla con otros, ya no siente simpatía por otros.
- c Las emociones desaparecen, dificultad para sentir alegría o tristeza.
- d Sensación de no tener sentimientos: anhedonía, abulia, pérdida de interés, aburrimiento.
- e Se siente profundamente cambiado, irreal o extraño.
- f Se siente despersonalizado, distanciado de sí mismo.
- g Pérdida del sentido de uno mismo (desconectado).

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

RESTRICCIÓN EMOCIONAL Y DEL YO

Escala de síntomas negativos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Se siente distante de otros. Sentimientos cotidianos apagados. Falta de emociones fuertes	Carece de emociones fuertes o de sentimientos definidos claramente (feliz, triste, enfadado, culpable, etc.)	Parece como si las emociones estuvieran desapareciendo, atenuadas o menos diferenciadas	Sensación de agotamiento, de aplanamiento o de tensión aversiva indiferenciada	Siente pérdida del sentido de sí mismo. Se siente despersonalizado, irreal o extraño. Puede sentirse desconectado de su cuerpo, del mundo, del tiempo. No tiene sentimientos la mayoría del tiempo	Se siente profundamente cambiado y posiblemente alienado de sí mismo. No tiene sentimientos

Puntuación basada en:

N.5. PENSAMIENTO EMPOBRECIDO

Pregunta

1. Evaluar de acuerdo con la observación de la entrevista y el informe colateral (cuando sea relevante).

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.5. DESCRIPCIÓN

- a Incapaz de darle un sentido a frases familiares o de comprender lo esencial de una conversación o de seguir una charla cotidiana.
- b Contenido verbal estereotipado. Fluidez, espontaneidad y flexibilidad de pensamiento disminuidas, como se evidencia en el contenido del pensamiento repetido o simple. Algo de rigidez en sus actitudes o creencias. No considera posiciones alternativas o tiene dificultad para cambiar de una idea a otra.
- c Estructura simple de palabras y de oraciones; escasez de oraciones subordinadas o de calificativos (adjetivos/adverbios).
- d Dificultad en el pensamiento abstracto. Desajustes en el uso del modo de pensamiento abstracto-simbólico más allá del pensamiento concreto o egocéntrico, como se evidencia en la dificultad de clasificación, en la formación de generalizaciones y en el procedimiento de tareas para resolver problemas; a menudo utiliza un modo concreto.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PENSAMIENTO EMPOBRECIDO

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Algunas dificultades en la conversación	Problemas para comprender matices de la conversación. Disminución en dar y recibir conversación	Interpreta correctamente la mayoría de las similitudes y proverbios. Usa pocos calificativos (adjetivos y adverbios). Pueden perderse algunos comentarios abstractos	A ratos pierde la esencia de la conversación razonablemente no complicada. El contenido verbal puede ser repetitivo y perseverante. Usa estructuras simples en palabras y oraciones sin muchos calificativos. Se pierde o interpreta muchas similitudes y proverbios concretamente	Capaz de seguir y responder a afirmaciones simples y preguntas, pero tiene dificultad para articular pensamientos y experiencias independientemente. Contenido verbal limitado y estereotipado. Expresión verbal limitada a oraciones simples, breves. Puede no ser capaz de interpretar la mayoría de las similitudes y proverbios	Incapaz de seguir cualquier conversación a ratos, sin importar cómo son de simples. Contenido verbal y expresión mayoritariamente limitada a palabras sueltas y respuestas de sí o no

Puntuación basada en:

N. 6. DETERIORO EN EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Preguntas

1. ¿Qué tipo de nuevas dificultades ha tenido para tener hechas las cosas (especialmente en la escuela/trabajo)? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Puede especificar cómo le está yendo en la escuela/trabajo? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N. 6. DESCRIPCIÓN

- a Dificultad para realizar las funciones de los roles (p. ej., trabajador, estudiante, amo/a de casa) que previamente realizaba sin problemas.
- b Tiene dificultad para las relaciones productivas, dirigidas a un fin, con los colegas en el trabajo o en la escuela.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

DETERIORO EN EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Requiere de más esfuerzo y concentración para mantener el mismo nivel de actuación en el trabajo, en la escuela y en las relaciones	Dificultad de funcionamiento en el trabajo, en la escuela y en las relaciones que es evidente para otros	Problemas determinados para realizar las tareas del trabajo o bajar un grado en las calificaciones de los estudios. Interacción social limitada	Suspense en uno o más cursos. Despido laboral o estar a prueba en el trabajo. Más conflictos o menos contacto con amigos, familia o colegas	Suspense, riesgo de fracaso escolar, u otra interferencia significativa completando los requerimientos. Ausencia problemática en el trabajo. Dificultades significantes con las relaciones	Fracaso o aislamiento escolar, ha abandonado el empleo o fue despedido. Incapaz de mantener relaciones con otros

Puntuación basada en:

D. SÍNTOMAS DE DESORGANIZACIÓN

D. 1. APARIENCIA O COMPORTAMIENTO RARO

Pregunta

1. ¿Qué nuevas aficiones o intereses especiales ha escogido? (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D. 1. DESCRIPCIÓN

- a Comportamiento o apariencia rara, excéntrica, peculiar, desorganizada o extraña.
- b Parece preocupado por los estímulos internos (alucinaciones...).
- c Afecto inapropiado.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

APARIENCIA O COMPORTAMIENTO RARO

Escala de síntomas de desorganización

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Apariencia o comportamiento cuestionablemente inusual	Comportamiento o apariencia que aparece mínimamente inusual o extraño	Comportamiento, intereses, apariencia, aficiones o preocupaciones extrañas, inusuales, que son consideradas fuera de las normas culturales. Puede exhibir comportamiento inapropiado	Comportamiento o apariencia que no es convencional para la mayoría de los patrones. Puede aparecer distraído por estímulos aparentes internos. Puede parecer desconectado o desimplicado	Comportamiento o apariencia altamente no convencional, extraña. Puede parecer preocupado por estímulos aparentes internos a ratos. Puede dar respuestas no contextuales, o exhibir afecto inapropiado	Apariencia o conducta ostensiblemente extraña (p. ej., coleccionar basura, hablar solo en público). Desconexión de afecto y habla

Puntuación basada en:

D. 2. PENSAMIENTO EXTRAÑO

Preguntas

1. ¿La gente le dice que sus ideas o que el modo en que piensa es raro o ilógico? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Piensa que las personas le dirían eso si compartiera sus ideas? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D. 2. DESCRIPCIÓN

- a Pensamiento caracterizado por ideas extrañas, fantásticas o extravagantes que están distorsionadas, son ilógicas o patentemente absurdas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PENSAMIENTO EXTRAÑO

Escala de síntomas de desorganización

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Ideas no frecuentes, peculiares, que son fácilmente abandonadas	Ideas inusuales ocasionales, pensamiento ilógico o distorsionado	Ideas inusuales persistentes, pensamientos ilógicos o distorsionados que se mantienen como una creencia o sistema filosófico dentro de la esfera de la variación subcultural	Pensamiento inusual o ilógico persistente que se acepta pero que viola el límite de la mayoría de los pensamientos filosóficos o religiosos	Construcción ilógica de ideas extrañas e irrealistas que son difíciles de seguir	Preocupado con pensamientos que son fantásticos, patentemente absurdos, fragmentados, e imposibles de seguir

Puntuación basada en:

D. 3. PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Preguntas

1. ¿Cómo ha sido su concentración? (anote la respuesta)
2. ¿Ha tenido alguna nueva/otra dificultad para permanecer concentrado? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D. 3. DESCRIPCIÓN

- a Fracasa manteniendo la atención, manifestado por una concentración escasa, distracción debida a estímulos internos y externos.
- b Dificultad en utilizar, cambiar o mantener la concentración en nuevos estímulos.
- c Problemas con la memoria a corto plazo incluyendo mantener la conversación en la memoria.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Escala de síntomas de desorganización

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Lapsus ocasionales de concentración bajo presión	Pérdida de atención ocasional en las tareas o conversaciones cotidianas	Problemas persistentes para mantener la atención y la concentración. Dificultad para mantener conversaciones	Generalmente distraído y pierde el hilo de la conversación con regularidad	Puede mantener la atención y permanecer concentrado sólo con la ayuda o el soporte exterior	Incapaz de mantener la atención incluso con refocalización exterior

Puntuación basada en:

D. 4. DETERIORO DE LA HIGIENE PERSONAL/HABILIDADES SOCIALES

Pregunta

1. ¿Ha notado algún cambio en cómo ha cuidado de sí mismo (p. ej., ducharse, cambiarse de ropa, etc.)?

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D. 4. DESCRIPCIÓN

- a Deterioro del arreglo e higiene personal. Falta de autocuidado.
- b Descortesía social. Aparta la mirada, aparece desimplicado o desconectado.
- c «Despistado» («en la Luna»), «ajeno al tema». Termina las conversaciones abruptamente, sin razones aparentes.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

DETERIORO DE LA HIGIENE PERSONAL/HABILIDADES SOCIALES

Escala de síntomas de desorganización

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Menos atención a la higiene personal pero todavía se interesa por las apariencias	Menos atención a la higiene personal y menos interés por la apariencia, pero todavía dentro de unos límites de convención y/o subcultura	Indiferencia ocasional hacia las convenciones y normas subculturales del vestir y de las pautas sociales	Falta de cumplimiento persistente de las normas subculturales o sociales de higiene. Ligeramente «despistado» o no atento socialmente	Fracaso e inestabilidad en las interacciones. Ya no se asea regularmente	Arreglado pobremente y parece no importarle o ni siquiera darse cuenta. Sin asear y puede presentar mal olor. Falta de atención y ausencia de respuesta a las pautas sociales incluso cuando se afrontan

Puntuación basada en:

G. SÍNTOMAS GENERALES

G. 1. ALTERACIONES DEL SUEÑO

Pregunta

1. ¿Cómo ha estado durmiendo? (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G. 1. DESCRIPCIÓN

- a Tiene dificultad para dormir.
- b Despertarse más temprano de lo deseado y no ser capaz de volver a dormir.
- c Fatiga y sueño durante el día.
- d Inversión del ciclo sueño/vigilia (día/noche).

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ALTERACIONES DEL SUEÑO

Escala de síntomas generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Duerme más inquieto de lo habitual	Ligera dificultad para dormirse o para volver a dormirse en caso de despertarse. Duerme más de lo habitual	Fatiga durante el día resultante de la dificultad para dormirse por la noche o de despertarse temprano. Pasa la mayor parte del día dormido	El patrón de sueño ha sido significativamente alterado e interfiere con otros aspectos del funcionamiento (p. ej., problemas para levantarse para ir a la escuela o al trabajo). Dificultad al levantarse para acudir a compromisos	Dificultad significativa para dormirse o despertarse temprano la mayoría de las noches. Puede tener inversión del ciclo sueño/vigilia. Generalmente no acude nunca a actividades programadas	Incapaz de dormir algo durante más de 48 horas

Puntuación basada en:

G.2. DISFORIA

Preguntas

1. ¿Se ha sentido deprimido (ansioso, irritable)? S N NI (anote la respuesta)
2. Valorar ideas de suicidio/homicidio, intención, plan. S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.2. DESCRIPCIÓN

- a Interés disminuido en actividades placenteras.
- b Problemas de sueño.
- c Apetito pobre o aumentado.
- d Sentimientos de pérdida de energía.
- e Dificultad para concentrarse.
- f Pensamientos suicidas.
- g Sentirse inútil y/o culpable.

TAMBIÉN

- a Ansiedad, pánico, múltiples miedos y fobias.
- b Irritabilidad, hostilidad, ira.
- c Inquietud, agitación, tensión.
- d Humor inestable.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

DISFORIA

Escala de síntomas generales

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Sentirse más a menudo «bajo» o «al límite»	Ocasionales períodos inestables y/o impredecibles de sentimientos «grises», tristes o malos, que pueden ser una combinación de depresión, irritabilidad o ansiedad	Sentimientos de decaimiento o de otras ansiedades o descontentos persistentes	Frecuentes períodos de tristeza, irritabilidad o depresión	Mezclas persistentes desagradables de depresión, irritabilidad o ansiedad. Comportamientos de evitación tales como dormir o el uso de sustancias	Combinaciones dolorosamente desagradables de depresión, irritabilidad o ansiedad que desencadenan comportamientos altamente destructivos tales como suicidio o automutilación

Puntuación basada en:

G.3. ALTERACIONES MOTORAS

Pregunta

1. ¿Ha notado algún cambio en la manera de moverse o en su coordinación? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.3. DESCRIPCIÓN

- a Se informa o se observa torpeza, falta de coordinación, dificultad para actuar en actividades que en el pasado eran realizadas sin problemas.
- b Desarrollo de nuevos movimientos tales como hábito nervioso, estereotipos, maneras características de hacer algo, posturas, o copiar los movimientos de otras personas (ecopraxia).
- c Bloqueos motores (catatonía).
- d Pérdida de habilidades motoras básicas.
- e Rituales motores compulsivos.
- f Movimientos discinéticos de cabeza, cara y extremidades.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ALTERACIONES MOTORAS

Escala de síntomas generales

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Torpeza	Se informa o se observa torpe	Coordinación pobre. Dificultad en realizar buenos movimientos motores	Movimientos estereotipados, a menudo inapropiados	Hábitos nerviosos, tics, muecas. Posturas. Rituales motores compulsivos	Pérdida de habilidades motoras básicas. Bloqueos motores. Ecopraxia. Discinesia

Puntuación basada en:

G.4. TOLERANCIA DETERIORADA AL ESTRÉS NORMAL

Pregunta

1. ¿Está sintiendo que no tiene tiempo para hacer sus actividades diarias porque se siente estresado o saturado? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.4. DESCRIPCIÓN

- a Evita o se agota con situaciones estresantes que eran previamente afrontadas con facilidad.
- b Síntomas marcados de ansiedad o de evitación a respuestas para los estresores diarios.
- c Afectado crecientemente por experiencias que eran fácilmente controladas en el pasado. Más dificultad para habituarse a las cosas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

TOLERANCIA DETERIORADA AL ESTRÉS NORMAL

Escala de síntomas generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Más cansado o estresado al final de un día normal	El estrés diario trae síntomas de ansiedad más allá de lo que pudiera ser esperado	Desestabilizado por acontecimientos inesperados en un día normal	«Amenazado» por experiencias diarias que eran fácilmente controladas en el pasado	Evita o está saturado por situaciones que previamente eran afrontadas con facilidad	Desorganización, pánico, abulia o aislamiento en respuesta al estrés diario

Puntuación basada en:

RESUMEN DE LOS DATOS SOPS

Escala de síndromes positivos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Síntomas positivos

	0	1	2	3	4	5	6	Totales
P.1. Contenido del pensamiento inusual/ideas delirantes	0	1	2	3	4	5	6	
P.2. Ideas persecutorias/susplicia	0	1	2	3	4	5	6	
P.3. Grandiosidad	0	1	2	3	4	5	6	
P.4. Percepciones anómalas/alucinaciones	0	1	2	3	4	5	6	
P.5. Comunicación desorganizada	0	1	2	3	4	5	6	

Escala de síntomas negativos, de desorganización, generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------------

Síntomas negativos

	0	1	2	3	4	5	6	Totales
N.1. Anhedonia social o aislamiento	0	1	2	3	4	5	6	
N.2. Abulia (apatía)	0	1	2	3	4	5	6	
N.3. Expresión emocional disminuida	0	1	2	3	4	5	6	
N.4. Restricción emocional y del yo	0	1	2	3	4	5	6	
N.5. Pensamiento empobrecido (comprensión y abstracción)	0	1	2	3	4	5	6	
N.6. Deterioro en el funcionamiento global	0	1	2	3	4	5	6	

Síntomas de desorganización

D.1. Apariencia o comportamiento raro	0	1	2	3	4	5	6
D.2. Pensamiento extraño	0	1	2	3	4	5	6
D.3. Problemas de atención y concentración	0	1	2	3	4	5	6
D.4. Deterioro de la higiene personal/habilidades sociales	0	1	2	3	4	5	6

Síntomas generales

G.1. Alteraciones del sueño	0	1	2	3	4	5	6
G.2. Disforia	0	1	2	3	4	5	6
G.3. Alteraciones motoras	0	1	2	3	4	5	6
G.4. Tolerancia disminuida al estrés normal	0	1	2	3	4	5	6